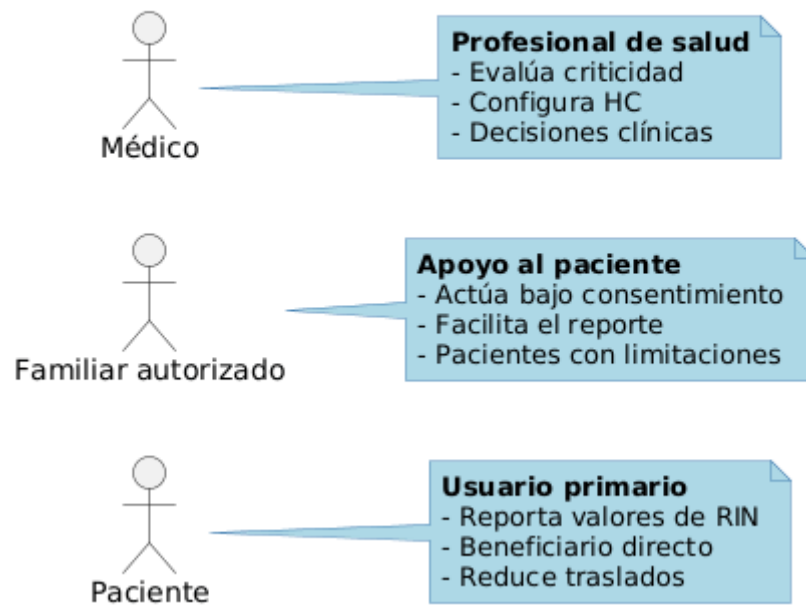
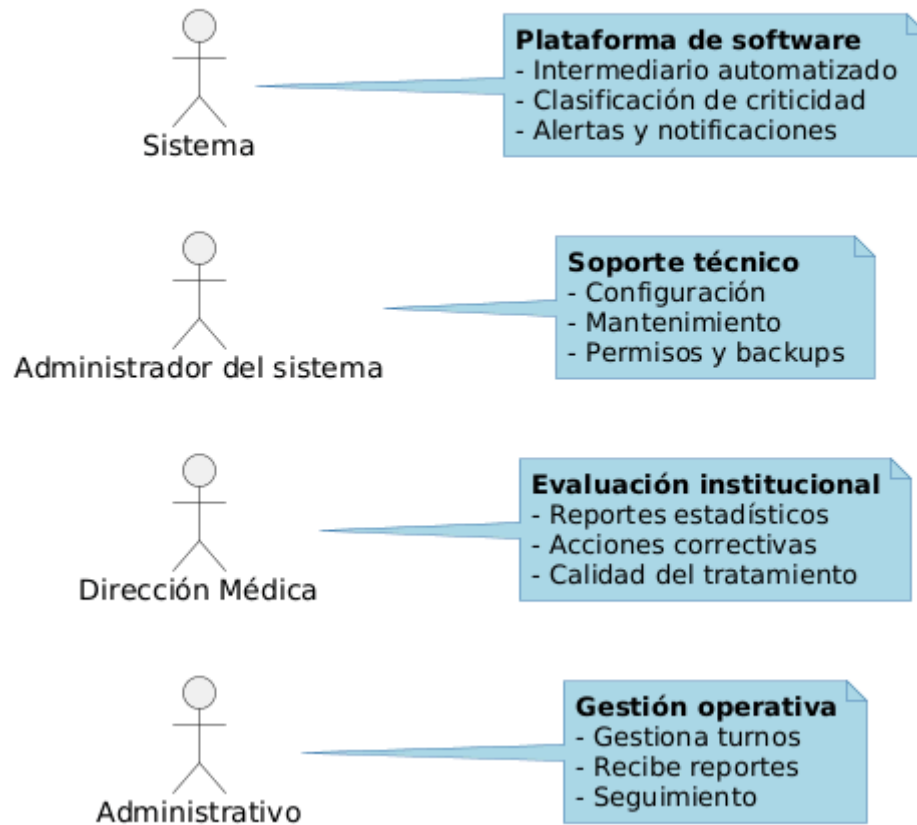


0.4 Stakeholders

Stakeholders - Parte A: Actores Clínicos y de Atención Directa



Stakeholders - Parte B: Actores Operativos e Institucionales



Actores y Partes Interesadas

Propósito

Este diagrama presenta a todas las partes interesadas (stakeholders) que tienen algún tipo de interés en la Plataforma Integral de Alertas y Monitoreo para Pacientes Anticoagulados o que interactúan con ella. La identificación se basa en los perfiles de acceso definidos en el TP1 y en los actores del negocio que participan en los procesos y casos de uso. Se han identificado siete stakeholders, organizados en dos grupos lógicos para facilitar su visualización.

Stakeholders identificados

Grupo A - Actores Clínicos y de Atención Directa:

1. Paciente

- Rol: Usuario primario del sistema.
- Interés:

- Reportar sus valores de RIN de forma remota sin necesidad de traslados innecesarios al centro de salud.
- Recibir seguimiento clínico oportuno cuando su estado lo requiera.
- Acceder a su historial de mediciones y mantener el control de su tratamiento.
- Beneficio directo: Reducción de viajes al centro, mayor comodidad y adherencia al tratamiento.

2. Familiar autorizado

- Rol: Apoyo al paciente.
- Interés:
 - Actuar en nombre del paciente bajo consentimiento registrado.
 - Facilitar el reporte de RIN cuando el paciente no puede hacerlo por sí mismo (limitaciones físicas, cognitivas o tecnológicas).
- Relación: Vinculado formalmente al paciente mediante autorización explícita.

3. Médico

- Rol: Profesional de la salud responsable del tratamiento.
- Interés:
 - Evaluar la criticidad de los reportes de RIN.
 - Configurar y actualizar las historias clínicas hematológicas.
 - Tomar decisiones de contacto urgente ante valores críticos.
 - Registrar eventos adversos y decisiones clínicas.
- Responsabilidad: Garantizar la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

Grupo B - Actores Operativos e Institucionales:

4. Administrativo

- Rol: Personal del centro de salud.
- Interés:
 - Gestionar turnos presenciales y optimizar la agenda médica.
 - Recibir reportes telefónicos de pacientes que no usan el portal.
 - Colaborar en el seguimiento de pacientes que no reportan a tiempo.
 - Ejecutar reasignaciones de turnos sugeridas por el sistema.
- Responsabilidad: Asegurar el funcionamiento operativo del centro.

5. Dirección Médica

- Rol: Responsables de la calidad institucional.
- Interés:
 - Evaluar los reportes estadísticos mensuales de eficacia del tratamiento.

- Identificar áreas de mejora en la atención.
 - Definir acciones correctivas (revisión de protocolos, capacitación).
 - Solicitar informes adicionales con diferentes enfoques.
- Responsabilidad: Garantizar que el centro cumpla con los objetivos institucionales de calidad.

6. Administrador del sistema

- Rol: Responsable técnico de la plataforma.
- Interés:
 - Configurar y mantener la infraestructura tecnológica.
 - Asignar permisos y gestionar usuarios.
 - Ejecutar y verificar copias de seguridad (backups).
 - Monitorear el rendimiento y la disponibilidad del sistema.
 - Resolver incidencias técnicas.
- Responsabilidad: Asegurar que el sistema esté operativo, seguro y cumpla con los requerimientos no funcionales.

7. Sistema

- Rol: La propia plataforma de software.
- Interés:
 - Actuar como intermediario automatizado en todos los procesos.
 - Clasificar automáticamente la criticidad de los reportes.
 - Generar alertas y notificaciones sin intervención humana.
 - Ejecutar reglas de negocio (tendencia peligrosa, estabilidad, reasignación).
- Característica: Stakeholder no humano pero esencial para el ecosistema.

Relación entre stakeholders

Todos estos stakeholders coexisten en el ecosistema del centro de salud hematológico, y la comprensión de sus roles es fundamental para asegurar que los requerimientos del sistema cubran sus necesidades reales. Cada stakeholder tiene un nivel de interacción diferente con la plataforma, desde el paciente que reporta valores hasta el administrador del sistema que garantiza su funcionamiento técnico.

Consideraciones especiales

- Paciente y Familiar: Son los usuarios con menor familiaridad tecnológica en muchos casos (adultos mayores), por lo que la usabilidad (REQ-NF-004) es crítica.
- Médico y Administrativo: Requieren formación específica sobre el uso del sistema.

- Dirección Médica: Necesita reportes claros y concisos para la toma de decisiones.
- Administrador del sistema: Debe contar con documentación técnica completa (REQ-NF-005).